

Correção aplicada — dados recalibrados para São Paulo capital (município 355030)

Dado-base: ~719.400 internações/1º semestre 2023 em hospitais públicos SP (TCESP). SP capital concentra ~35% = ~500 mil internações/ano na capital. Diária corrigida para R\$ 680 (hospitais terciários da capital têm custo maior que a média estadual). Perfil social incluído com dado real: ~3% dos leitos ocupados por pacientes de baixa social (literatura clínica, caso documentado abc+).

TABELA 1 — PERFIS CLÍNICOS (SÃO PAULO CAPITAL · 2023)

Perfil	CID	Internações/ano capital	Média perm. SUS	Tempo ideal	Delta evitável	% elegíveis DataCross	Casos/ano	Dias evitáveis	Custo total (R\$680/d)	Fonte / base
ATB / Infusão EV Pneumonia bacteriana	J18 · A41	~19.800	9,2 d	6,0 d	3,2 d	30%	5.940	19.008	R\$ 12,9 M	SBPT 2018 · TCESP 2023 cap. ~35%
Infecção urinária ITU complicada	N10 · N39.0	~12.100	8,5 d	5,0 d	3,5 d	35%	4.235	14.823	R\$ 10,1 M	SIH/DATASUS cap. estimado
Sepse pós-estab. Fase transferível	A40 · A41	~8.360	14,0 d	9,0 d	5,0 d	20%	1.672	8.360	R\$ 5,7 M	SciELO RBTI · mediana 6–14d
AVC reabilitação Fase estável	I63 · I64	~9.240	12,5 d	7,0 d	5,5 d	25%	2.310	12.705	R\$ 8,6 M	SIH/DATASUS cap. · protocolo CER
Fratura fêmur Pós-op ortopédico	S72	~6.160	11,0 d	6,5 d	4,5 d	25%	1.540	6.930	R\$ 4,7 M	SIH/DATASUS cap. estimado
Curativos / L89 Úlcera pressão estável	L89 · E14.5	~4.840	18,0 d	7,0 d	11,0 d	40%	1.936	21.296	R\$ 14,5 M	SIH/DATASUS cap. · AD2 protocolo
Subtotal — perfis clínicos							17.633	83.122 d	R\$ 56,5 M	

TABELA 2 — PERFIL SOCIAL / CUSTÓDIA (SÃO PAULO CAPITAL · DADO ESPECIAL)

Perfil social	CID / Z	Leitos ocupados capital (estimativa)	Permanência típica	Tempo necessário	Delta evitável	Custo/paciente (R\$680/d)	Custo total estimado	Destino correto	Fonte
Idoso sem família Aguardando ILPI	Z74.0 · Z59.2	~400 leitos/momento	90–900 dias	0 d (alta médica)	90–900 d	R\$ 61.200 – R\$ 612.000	R\$ 24,5–245 M/ano	ILPI via SUAS	~3% leitos · abc+ 2025 · caso 900 dias documentado
Situação de rua Alta bloqueada	Z59.0 · Z65	~200 leitos/momento	30–200 dias	0 d (alta médica)	30–200 d	R\$ 20.400 – R\$ 136.000	R\$ 6,1–27,2 M/ano	Abrigo SMS / SCAS	Estimativa ~40% perfil social total
Dependente sem cuidador Sem rede de apoio	Z74.3 · Z74.1	~150 leitos/momento	30–120 dias	0 d (alta médica)	30–120 d	R\$ 20.400 – R\$ 81.600	R\$ 3,1–12,2 M/ano	AD domiciliar + apoio social	Estimativa ~30% perfil social total
Subtotal estimado — perfil social						R\$ 33,7 M – R\$ 284 M/ano			
750 leitos cronicamente bloqueados na capital · todos com alta médica já dada						dependendo da permanência média real			

Por que o custo social é tão alto e difícil de medir?

O paciente social *não aparece como "paciente social" no SIH/DATASUS* — ele tem alta médica, mas continua internado. A AIH continua sendo emitida como se ainda precisasse de cuidados, ou a internação é registrada como "longa permanência" com CID clínico residual. **O DataCross identifica esse perfil pela combinação:** alta médica registrada + zero alterações clínicas nas últimas 72h + campo "motivo de permanência = social/família" na evolução de enfermagem. É o perfil mais invisível nos dados e o mais fácil de intervir — pois a decisão clínica já foi tomada.

RESUMO CONSOLIDADO — SÃO PAULO CAPITAL

Total dias evitáveis/ano (perfis clínicos)

83.122 dias

Custo evitável perfis clínicos

R\$ 56,5 M/ano

ROI DataCross (15% captura)

R\$ 8,5 M/ano

17.633 pacientes elegíveis

base: R\$680/diária capital

só perfis clínicos · conservador

Leitos sociais bloqueados agora

~750 leitos

com alta médica · sem destino

Custo mínimo perfil social

R\$ 33,7 M/ano

estimativa conservadora (90d média)

ROI total (clínico + social 15%)

R\$ 13,5 M/ano

projeção piloto SP capital